

Cure de prolapsus par voie vaginale avec greffe ou treillis synthétique **WARWIKI**

Information pour le patient · Renforcement d'une cure de prolapsus par un matériau de soutien

Certaines cures de prolapsus par voie vaginale sont renforcées par une **greffe** — un matériau de soutien ajouté là où vos propres tissus sont fragilisés. Il peut s'agir d'une **greffe biologique** ou, dans des situations précises, d'un **treillis synthétique**. Cette fiche vous explique honnêtement les options, notamment l'historique de sécurité du treillis transvaginal, afin que vous puissiez faire un choix éclairé avec votre chirurgien.

À propos de cette intervention

Par une incision vaginale, la paroi affaiblie est réparée et une greffe est mise en place pour renforcer la solidité et réduire le risque de récurrence du prolapsus. Les matériaux utilisés sont :

- **Greffe biologique** — issue de tissu humain donné ou d'origine animale ; elle est progressivement absorbée par l'organisme au fil de la cicatrisation.
- **Treillis synthétique** — matériau permanent, utilisé **de façon sélective** après une information approfondie.

Contexte de sécurité important

Le **treillis synthétique transvaginal** pour le prolapsus a fait l'objet d'**avertissements de la FDA** et n'est plus commercialisé à cet usage aux États-Unis en raison de risques tels que l'exposition du treillis et la douleur. Aujourd'hui, le prolapsus est le plus souvent traité par réparation avec les **tissus natifs** ou une greffe biologique ; le treillis abdominal (comme dans la sacrocolpopexie) reste une option distincte et bien documentée. Votre chirurgien vous expliquera précisément quel matériau est prévu et pourquoi.

COMPRENDRE LES TERMES

Prolapsus

Descente d'un organe pelvien provoquant une sensation de boule ou de pression.

Greffe

Matériau de soutien placé lors de la réparation.

Greffe biologique

Matériau d'origine tissulaire absorbé par l'organisme avec le temps.

Treillis synthétique

Matériau permanent ; son usage transvaginal pour le prolapsus est restreint.

Réparation par tissus natifs

Réparation utilisant uniquement vos propres tissus, sans greffe.

Exposition du treillis

Quand une partie du treillis devient visible ou palpable ; peut causer douleur ou écoulement.

DOIS-JE M'INQUIÉTER DU TREILLIS ? C'est une question légitime. Les problèmes à l'origine des avertissements concernaient spécifiquement le **treillis synthétique transvaginal pour le prolapsus**. Les réparations par tissus natifs, les greffes biologiques et le treillis abdominal ont des profils de sécurité différents, bien étudiés. L'essentiel est de comprendre précisément ce que votre chirurgien prévoit et pourquoi — posez la question.

Questions à poser à votre chirurgien

- **Quel matériau** utiliserez-vous — tissus natifs, greffe biologique ou treillis synthétique — et pourquoi dans mon cas ?
- Quels sont les **risques spécifiques**, notamment l'exposition du treillis ou la douleur lors des rapports ?
- Quelles sont mes **alternatives** (réparation par tissus natifs, sacrocolpopexie, pessaire) ?
- Quel est le risque de **récidive** du prolapsus avec chaque option ?

Comment vous préparer

- Suivez les consignes d'**anesthésie** (jeûne, arrêt des anticoagulants si prescrit).
- Ne fumez pas ; prévoyez un accompagnant et de l'aide à domicile.
- Planifiez plusieurs semaines d'activité légère et de repos pelvien.

Après la chirurgie

- Des pertes ou écoulements légers pendant quelques semaines sont normaux.
- **Évitez les efforts, les poussées et les rapports sexuels pendant environ 6 semaines.**
- Gardez les selles molles ; reprenez les activités progressivement.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre, des frissons ou des saignements abondants
- Une **incapacité à uriner** ou une douleur qui s'aggrave
- Plus tard : **douleur lors des rapports**, écoulement inhabituel, ou votre partenaire perçoit quelque chose (possible exposition du treillis)

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Une greffe renforce la cure de prolapsus vaginal — les greffes biologiques sont absorbées progressivement ; le treillis synthétique est permanent et utilisé de façon sélective.
2. Le treillis transvaginal pour prolapsus a fait l'objet d'avertissements de la FDA ; la réparation par tissus natifs et les greffes biologiques sont courantes, et le treillis abdominal est une option distincte.
3. Demandez précisément quel matériau est prévu et pourquoi. Signalez toute douleur ultérieure lors des rapports ou tout écoulement inhabituel.